



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ريم محمد محمد قطب

العنوان : 23 خالد بن الوليد بولاق
الذكرور الجيزة

الحي / المدينة : بولاق الدكرور

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

رقم البطاقة : 27603060101327 رقم التليفون : 01147171771

العمر (تاريخ الميلاد) : 06-03-1976 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) قسم العلاج
الاورام [14152]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ريم محمد محمد قطي National ID: 27603060101327	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Docetaxel chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ریم
محمد محمد قطب

ع ١١٤٢ مشروع ١١٨٥ اماره حدائق اکتوبر
ثالث ٦ اکتوبر - الجیزه

١٩٧٦/٠٣/٠٦ ٢٧٦.٣.٠٦.٠١.١٣٢٧

JR0152561

١١٤٢/١٧/١٧/١٧

٢٠٢٢/١١ ٢٧٦.٣.٠٦.٠١.١٣٢٧

حاصله على التثويه العلميه

أنتى مملعة أرمله

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١١/٢٣

١

Pathology request form

*Patient Name:

*Hospital Number:

*Date of Birth:

*Sex:

Male

☐

Female

☒

*Requesting Physician:

*Department:

*Clinical data:

newly diagnosed case of breast cancer
I need of Tissue for PR. Hr

Specimen data:

Number Of specimens:

*Time Taken

*Time into Fixative

1.	:	:
2.	:	:
3.	:	:
4.	:	:
5.	:	:

Sent by

Department/Site

 Number of
Containers
()

Lab Use Only

① Block (1824/26) + ⑤ slides

Demographics Checked	Initials
Received number of Containers ()	
Accessioning	
Grossing	
Embedding/Microtomy:	
Pathologist	

Time out of Formalin

Time submitted to pathologist

*Must be filled.

Issue date: 9/3/2021

Version No.: 2/0

Form code: F/SOP/PI/20/01

Name: ريم محمد محمد قطب		
MR. : 11570		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
13/5: Left diffuse skin thickening with underlying trabecular thickening with multiple variable size obscured lesions seen, along with UOQ area of architecture distortion seen. US showed 2-3:00 area of parenchymal distortion showing internal vascularity with color doppler study measuring 4.3x2.2 c 7/6/2026: CT CAP: Left breast multiple heterogeneously enhancing (mainly peripheral) lesions are seen, the largest component is seen at the retroareolar measuring about 7.2x4.2 cm, associated with increased skin thickness as well as retracted left nipple. Multiple enlarged left axillary level I, II and III lymph nodes are seen; the largest is seen at level I measuring about 1.6x1.9 cm. Multiple bilateral small supraclavicular lymph nodes are noted; the largest seen at the left side measuring 0.9x0.6 cm. Enlarged left internal mammary lymph node measuring 0.9x0.6 cm Multiple bilateral pulmonary scattered tiny pulmonary nodules are seen, the largest is right lower lobar fissural measuring about 5mm. Multiple small prevascular, pretracheal and retrocaval lymph nodes are seen, the largest is seen at the retrocaval group measuring about 1.2 x1 cm MDt >> For Portacath insertion NACT AC x 4 --> 4 TCHP Then re-assess for Lt MRM after assessment of response today for C1 Ac + supp ttt after labs ECHO 13-7-2026 >> 65 % Wt 76 HT 155 fir c2 AC, after labs, accepted, for liver support, mildly elevated liver enzymes		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	Reham Ahmed Fathy Ibrahim	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

MRN: 2021156933
Patient Name: REEM MOHAMMED MOHAMMED KOTB D.O.B: 06/03/1976
IC No.: 27603060101327 Sex: Female
Location: External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY

Her2 Receptors

Specimen Id 2605310158
Accession No IMM-26-2051
Sample Type Paraffin Block
Collection Date 31/05/2026 01:53 PM
Received Date 31/05/2026 01:54 PM
Doctor Mohamed Mohamed Gaber Abdelsalam

Immunohistochemical Report

pathology number
1824/26

Clinical Data
Lt. breast cancer

Gross Picture :
Referred block submitted for HER 2 immunostaining.

System Used :
Ventana BenchMark ULTRA autostainer.

Antibody:
Ventana anti-HER-2 [4B5] rabbit monoclonal antibody.

Scoring system :
Reference: ASCO-CAP HER2 Test Guideline Recommendations, 2018. IHC 0 :as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within $\leq 10\%$ of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within $>10\%$ of the invasive tumor cells. IHC 2+: The revised definition of IHC 2+ (equivocal) is weak to moderate complete membrane staining observed in $>10\%$ of tumor cells.. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense in $>10\%$ of tumor cells.

Laterality :
Left

Her2 Result
Positive [score 3+]

Signature
Dr. Hazem Abdelazim, MD, IFCAP



MRN: 2021156933
 Patient Name: REEM MOHAMMED MOHAMMED KOTB
 IC No.: 27603060101327
 Location: External Clinic
 D.O.B: 06/03/1976
 Sex: Female

SURGICAL PATHOLOGY

Biopsy Small - (1 Site)

Specimen Id 2605250143
Accession No SUR-26-1824
Sample Type Tissue
Collection Date 25/05/2026 12:07 PM
Received Date 25/05/2026 12:07 PM
Doctor radwa alaa eldien Mohamed abdefattah

Clinical Information

Left breast lesion at 2-3 O'clock (BIRADS 5).

Gross Picture

Multiple grayish tissue cores 0.5-1.3 cm long, totally submitted.

Microscopic Picture

A case of invasive duct carcinoma, grade 3. Evidence of high grade ductal carcinoma insitu, solid type. scattered lymphovascular emboli detected . Stroma is desmoplastic with mild inflammatory cell reaction.

Diagnostic Summary

Tumour type:

Invasive duct carcinoma, NST

Laterality

Left

Specimen type:

U/S guided core biopsy.

Location

2-3 O'clock

Histological grade

Mitosis score (1-3):

3

Tubular formation score (1-3):

3

Nuclear grade (1-3):

3



MRN: 2021156933
Patient Name: REEM MOHAMMED MOHAMMED KOTB
IC No.: 27603060101327
Location: External Clinic
D.O.B: 06/03/1976
Sex: Female

SURGICAL PATHOLOGY

Biopsy Small - (1 Site)

Specimen Id 2605250143
Accession No SUR-26-1824
Sample Type Tissue
Collection Date 25/05/2026 12:07 PM
Received Date 25/05/2026 12:07 PM
Doctor radwa alaa eldien Mohamed abdefattah

Clinical Information

Left breast lesion at 2-3 O'clock (BIRADS 5).

Gross Picture

Multiple grayish tissue cores 0.5-1.3 cm long, totally submitted.

Microscopic Picture

A case of invasive duct carcinoma, grade 3. Evidence of high grade ductal carcinoma insitu, solid type. scattered lymphovascular emboli detected . Stroma is desmoplastic with mild inflammatory cell reaction.

Diagnostic Summary

Tumour type:

Invasive duct carcinoma, NST

Laterality

Left

Specimen type:

U/S guided core biopsy.

Location

2-3 O'clock

Histological grade

Mitosis score (1-3):

3

Tubular formation score (1-3):

3

Nuclear grade (1-3):

3



MRN: 2021156933
Patient Name: REEM MOHAMMED MOHAMMED KOTB D.O.B: 06/03/1976
IC No.: 27603060101327 Sex: Female
Location: Surgical Oncology

CYTOPATHOLOGY

Fine Needle Aspiration Cytology - (1 Site)

Specimen Id 2407160355
Accession No CYTO24-855
Sample Type Fluid/ Smear
Collection Date 16/07/2024 03:03 PM
Received Date 16/07/2024 03:03 PM
Doctor Yassmin Mohamed Hassan Riad

Nature of Specimen:

U/S-guided aspiration cytology from Rt. breast 12 O'clock cyst.

Gross Picture:

Received 18 ml of greyish fluid, Four smears were prepared, Pap-stained.

Microscopic Picture:

Hypocellular smears show few histocytes in a proteinaceous material. No atypia or malignancy in examined material.

Diagnosis:

Rt. breast cyst, U/S-guided aspiration cytology:
Hypocellular, negative for malignancy.

Comments:

Recommended for clinic-radiologic correlation.

Signature

MONA MOHAMED MAMDOH

Reported and electronically endorsed by

Mona MOhamed Mamdouh Abdelfattah

Pathology lab director:

Dr. Hazem Abdelazim, MD, IFCAP

Validated on 20/07/2024 02:36 PM

Print Date:

10/06/2026 10:01 AM

Page Number: 1 of 1



www.Baheya.org



16602

مركز بهية الهرم
4 شارع علوية أول شارع الهرم بجوار داري , الجيزة

مستشفى بهية الشيخ زايد
كلية الهندسة
[REPORTING PATHOLOGIAN REPORT]

MRN: 2021156933
Patient Name: REEM MOHAMMED MOHAMMED KOTB D.O.B: 06/03/1976
IC No.: 27603060101327 Sex: Female
Location: External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY

Hormone receptors

Specimen Id 2605310159 Collection Date 31/05/2026 01:54 PM
Accession No IMM-26-2050 Received Date 31/05/2026 01:54 PM
Sample Type Paraffin Block Doctor Mohamed Mohamed Gaber Abdelsalam

Immunohistochemical Report

pathology number
1824/26

Clinical Data

Lt. breast cancer

Gross Picture :

Referred block submitted for ER/PR immunostaining.

System Used :

Ventana BenchMark ULTRA autostainer.

Antibody:

Ventana anti-PR[1E2] Rabbit monoclonal antibody, Ventana anti-ER[SP1] Rabbit monoclonal antibody.

Scoring system :

According to the ASCO/CAP guideline update, 2019 : Samples with 1% to 100% of tumor nuclei positive for ER or progesterone receptor (PgR) are interpreted as positive. If ER (not PgR), 1% to 10% of tumor cell nuclei are immunoreactive, the sample are reported as ER Low Positive. A sample is considered negative for ER or PgR if < 1% or 0% of tumor cell nuclei are immunoreactive.

Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Comment:

- There are much more limited data on the 2% to 3% of cancers that are low ER expressers (most often defined as 1%-10% ER-positive cells by IHC) and their potential benefit from endocrine therapy.

